Časová naléhavost: RUTINA *Objednal:* Chirurgie - stanice B

Laboratorní vyšetření

Ze dne:

Pacient 6

Dat. nar.: *Č. poj.:* **623456/6666**

Bydliště: *Kód poj.:*

Histologie

B_AA Lokalizace 1 Text...

B_AA Lokalizace 1

PRŮVODNÍ LIST K ZÁSILCE BIOPTICKÉHO MATERIÁLU
----------Vyšetřovací
číslo:
Datum odběru: Datum příjmu:1 Žadatel vyšetření:9 Datum odeslání:
Klinická diagnóza:C504
TOPOGRAFIE ODBĚRU: prs vlevo
KLIN. DIAG.:
ca. prsu vlevo ZKK

preparát.
porce prsu s tumorem, který značen i mag seed, mediálně modrý steh, laterálně bílý steh, ventrálně dlouhý bílý steh

DIAGNÓZA: C504
CHIRURGICKÉ VYŠ.:
lumpectomia e mamma l.sin.

NÁLEZ:
1/1
2729/2026
Makropopis:
V nádobě označené "část prsu l. sin." zaslána porce mléčné žlázy hmotnosti 34,6 g a velikosti 6,5 x 4,5 x 2,5 cm. Resekát je klinikem značen modrým stehem mediálně, bílým stehem laterálně, dlouhým bílým stehem ventrálně, proto ventrální resekční plochu barvím zelenou tuší, dorsální resekční plochu barvím černou tuší. Kraniální a kaudální resekční plochu modrou tuší. Na řezech je zastiženo ložisko velikosti 1,6 x 1,5 x 1,5 cm, které je bělavožluté barvy, tužší konzistence, v centru s kovovým klipem a makroskopicky je v těsné blízkosti ventrální resekční plochy.

Mikropopis:
(1) a-v) Tkáň mléčné žlázy, kde v terénu fibrocystických změn zastiženy struktury invazivního NST karcinomu, skóre dle modifikované Nottinghamské klasifikace 3 + 2 + 1 = 6, středně diferencovaný G2, v IHC: GATA3 pozitivní, p120 pozitivní membránově, p63 a CK14 negativní myoepiteliální lemy. Lymfangioinvaze zastižena. Angioinvaze nezastižena. Bez známek perineurálního šíření. Dále v okolí tumoru zastiženy struktury DCIS bez EIC. Tumor je v těsné blízkosti ventrální resekční plochy barvené zelenou tuší, a to méně než 1 mm. Dále také v těsné blízkosti dorzální resekční plochy barvené černou tuší, a to méně než 1 mm.

Závěr:

1. velikost tumoru - 1,6 x 1,5 x 1,5 cm
2. typ nádoru - invazivní karcinom NST
3. grading nádoru - G2

4. skóre nádoru dle modifikované "Nottinghamské klasifikace" - 3+2+1=6
5. angioinvaze - ne
6. invaze do lymfatik - ano
7. Imunohistochemické vyšetření:

E-CAD (DAKO, klon NCH-38)..... pozitivní
Ki67 (Zytomed, klon SP6)..... 10 %
ER (Novocastra, klon 6F11/2)..... 100 %
PR (Novocastra, klon 312/2)..... 0 %
Her2neu (Ventana, klon 4B5)..... 0 (negativní)

8. resekční linie - tumor v těsné blízkosti ventrální a dorzální resekční linie (méně než 1 mm)
9. sentinelová lymfatická uzlina - dodány 2 LU, v 1 LU mikrometastáza velikosti 2 mm, bez známek invaze přes pouzdro (2/1)
10. pTNM - pT1c pN1mi
moh

Dodatek nálezu -
Výsledek vyšetření MammaPrint (2026/1444)
ŽÁDANKA:
Žadatel:

Předmět vyšetření a lokalizace: Prosím o vyšetření Mammaprint.
K vyšetření: 1 blok bio č. 2729_2/26.
Klinická diagnóza a dotaz: Karcinom prsu
Požadovaná vyšetření: Mammaprint [T]

Mammaprint:
Závěr: High Risk (H1) Luminal B

Popis: MammaPrint Index: -0,258
BluePrint Molecular Subtype Result: Luminal Type
Klasifikace: high risk

Závěr:
Výsledek testu MammaPrintR klasifikoval pacientku do skupiny s vysokým rizikem vzniku metastáz (HIGH RISK (H1) LUMINAL B) během prvních 10 let po diagnóze.

U této skupiny MÁ CHEMOTERAPIE PŘÍNOS (intenzifikace léčby s antracykliny nepřináší dostatečný benefit).

M1: M85003 KARCINOM INVAZIVNI NOS, DUKTALNI INFILTR G: P:1
M2: G: P:
M3: G: P:
TOP: T0403 PRS SIN